三、主动脉瓣狭窄

（一）病因

①先天性畸形 中老年人高血压、高血脂、吸烟、糖尿病 严重主狭+胃肠道血管发育不良

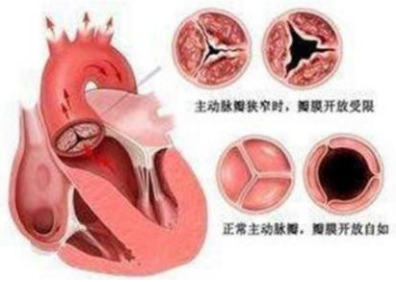
②**退行性老年主动脉瓣钙化**：危险因素类似冠心病，患者可伴隐匿性胃肠道出血（海德 Heyde 综合征老人与海）

③风湿病 VS 梅毒:绝少钙化

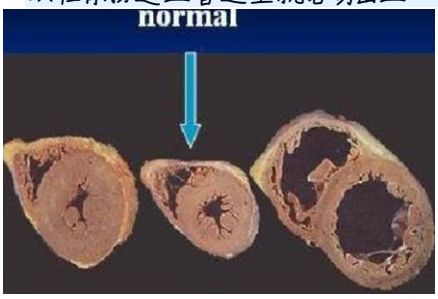
主动脉瓣狭窄→主动脉射血↓流到冠脉的血↓
↓
心绞痛

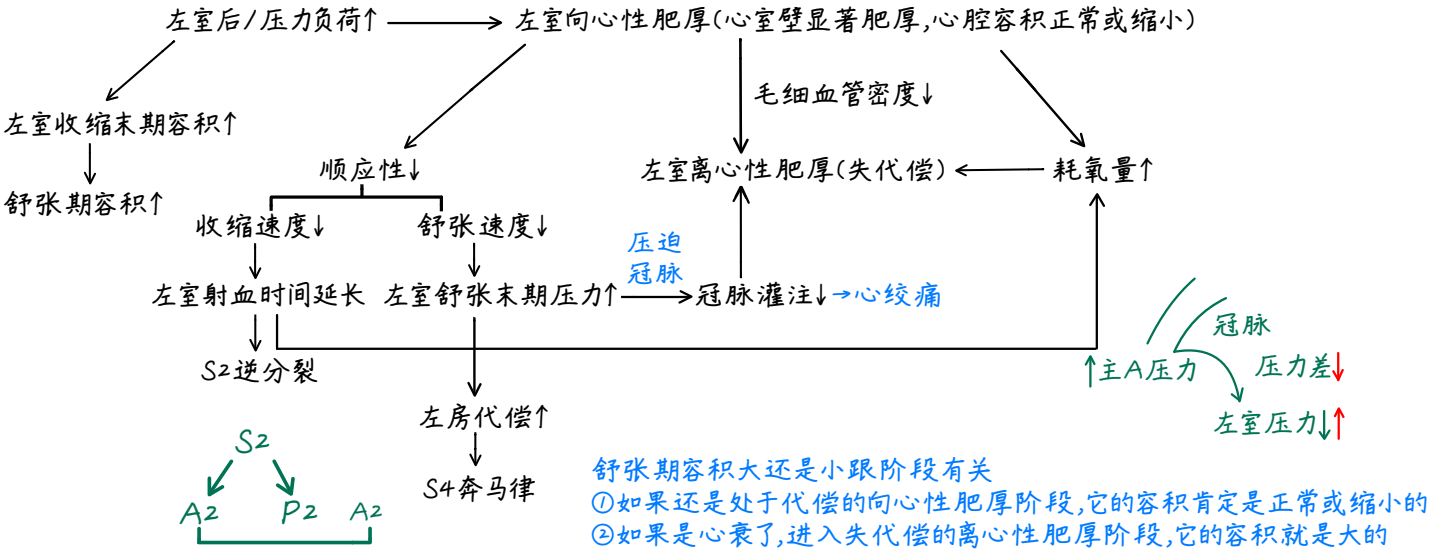
严重主狭时,左心室用力将血通过狭窄的瓣膜,会产生一种高速紊乱的射流,这种射流带来一种剪切力破坏血管当中VWF→8因子不稳定→凝血障碍致出血患者本身又有胃肠道血管的发育不良,所以在胃肠道血管这里就容易出血

（二）左室血进入主动脉受阻







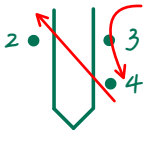


舒张期容积大还是小跟阶段有关
①如果还是处于代偿的向心性肥厚阶段,它的容积肯定是正常或缩小的
②如果是心衰了,进入失代偿的离心性肥厚阶段,它的容积就是大的

肥厚心肌顺应性↓→舒张速度↓,收缩速度↓,
使射血时间延长,导致主动脉瓣关闭明显延后

①压力负荷增大的疾病(高血压、主狭)一开始是向心性肥厚代偿,最后离心性肥厚
②容量负荷增加的疾病(慢性主闭、慢性二闭)一开始就通过离心性肥厚代偿

（三）临床表现



心脏在射血时,它的射血速度是先增后减的
左心室的心肌收缩力跟杂音相关也呈现递增递减

1.杂音

①**胸骨右缘 2 肋间、收缩期、递增-递减型杂音，常喷射样/射流样、向颈部传导**。有些老年人由于主动脉瓣严重钙化、杂音可能在心尖部最清楚 杂音反弹到心尖

②杂音越响、持续时间越长、高峰出现越晚，提示瓣膜狭窄程度越重

③主狭伴主闭时主狭的杂音会增强 主闭反流,左心室血↑→更多血液在收缩期通过狭窄的主动脉瓣